

Les aspects communicationnels de la rencontre avec le malade et sa famille

Dr Bououden
Université3 de Constantine

I. Introduction:

- L'entretien entre le médecin et le patient constitue le fondement d'une bonne prise en charge.
- Les patients veulent être entendus quand il s'agit de diagnostiquer et, le cas échéant, de traiter leurs plaintes.
- La communication est une conduite psychosociale visant à transmettre une information par l'emploi du langage, des gestes, des attitudes ou des mimiques.

II. Historique

- Au début des années 70, des experts ont, pour la première fois, analysé des entretiens entre médecins et patients et observé que la communication était pauvre et largement inadéquate.
- Les médecins interrompaient fréquemment le récit des patients après moins d'une minute, passant ainsi quelquefois à côté d'informations importantes sur leur état.
- Certains patients ne comprenaient pas les informations communiquées par leur médecin et lorsqu'ils quittaient le cabinet, ne savaient ni ce que leur médecin venait de leur expliquer, ni ce qu'ils devaient faire.

III. RELATION, COMMUNICATION, INFORMATION

- Ces termes méritent d'être précisés. Ils recouvrent des réalités voisines mais différentes :
 - **La relation entre le soignant et son malade** : il s'agit du climat de confiance pouvant s'installer entre des individus. Un exemple type de tels phénomènes est le sentiment d'être suffisamment informé.
 - **La communication** : est un échange de messages entre les personnes. Elle suppose l'existence d'émetteurs et de récepteurs — ce sont les soignants et les soignés — ainsi qu'un système de transport de messages par vecteurs verbaux, écrits ou comportementaux dans un espace d'expansion défini.
 - **Quant à l'information** : c'est le contenu du message.

IV. Processus de la communication:

- **Le schéma de la communication** se présente comme ceci « **Schéma de Shannon1** » :

Annexe I : Schéma de Shannon



- **Les cinq axiomes concernant la communication:**
 1. On ne peut pas ne pas communiquer.
 2. Toute communication présente deux aspects: le contenu et la relation.
 3. La communication est toujours à la fois cause et effet.
 4. La communication humaine utilise deux modes de communication: digitale et analogique.
 5. La communication est soit symétrique, soit complémentaire (dans le domaine de la santé, car il met en évidence que la communication n'est pas toujours symétrique (comme c'est le cas quand les rapports de force sont équilibrés), mais qu'elle peut aussi être complémentaire quand des différences importantes séparent les participants).

V. Outil pour une bonne communication

- Plusieurs outils ont été élaborés en vue d'améliorer la communication. C'est le cas du cadre SEGUE, conçu par l'Université Northwestern de Chicago (Illinois, États-Unis):
 - **Set the stage** (préparer l'entretien)
 - **Elicit information** (obtenir des informations)
 - **Give information** (fournir des informations)
 - **Understand the patient's perspective** (comprendre le point de vue du patient)
 - **End the encounter** (mettre un terme à l'entretien).

VI. Techniques de communication de base

- **EPICES : un outil de communication**
- L'outil de communication EPICES, « Environnement, Perception, Invitation, Connaissances, Empathie, Stratégies et Synthèse », peut être employé pour aider pour faciliter la communication avec les patients
- **Étape 1 : écouter (E)**
- **Confidentialité.** L'environnement joue un rôle important lorsque des sujets sensibles doivent être abordés. Le patient doit pouvoir écouter et poser des questions sans être dérangé.
- **Faire participer les êtres chers :** Il faut toujours demander aux patients s'ils souhaitent qu'un membre de leur famille ou un proche soit présent pour les soutenir et les aider à assimiler les informations.
- **S'asseoir:** cela permet une communication directe et montre au patient que le professionnel souhaite prendre son temps.
- **Écouter :** L'écoute des patients, sans les interrompre, est une tâche importante du professionnel de santé. Garder le contact visuel et le silence est une bonne façon de Manifester son intérêt et sa bienveillance au patient.
- **Étape 2 : percevoir (P)**
- Il s'avère souvent judicieux de demander au patient son avis sur la situation. Cela peut aider le professionnel de santé à comprendre ce que le patient a intégré de sa situation.
- **Étape 3 : inviter (I)**
- Quel volume d'informations on doit fournir au patient ? :
- Chaque patient est différent, donc se concentrer sur chacun d'eux afin d'identifier ce qu'ils veulent savoir et le volume d'information qu'ils souhaitent obtenir.
- **Étape 4 : connaître (C)**

- Pour communiquer efficacement avec les patients, il faut toujours les prévenir que des informations difficiles vont leur être communiquées. Les patients ont ainsi le temps de se préparer, même s'il ne s'agit que de quelques minutes.

Étape 5 : explorer (E)

- Pour être attentifs aux besoins émotionnels des patients:
 - **Naming** : nommer les émotions: Écoutez et identifiez les émotions du patient. Si vous n'êtes pas sûr des émotions qui sont exprimées ou ressenties, posez des questions telles que : *Que ressentez-vous ?*
 - **Understanding** : dans la mesure du possible, exprimer de la compréhension pour ces émotions
 - **Respecting** : exprimer du respect ou de la reconnaissance pour le patient
 - **Supporting** : apporter son soutien au patient
 - **Exploring** : investiguer d'autres aspects propres aux émotions
- Gardez le silence. Parfois, le plus important est d'être présent, de laisser le patient intégrer les informations et de lui donner une chance de poser des questions.

Étape 6 : synthétiser

A la fin de la consultation, il est toujours judicieux de résumer les informations abordées. Les patients peuvent avoir des questions supplémentaires ou se souvenir de quelque chose d'important

VII. Objectifs de la communication :

Les objectifs de la communication entre le médecin et le patient :

1. Recueillir des informations;
2. Informer le patient;
3. Tenir compte des sentiments du patient.
4. Développer, entretenir et conclure une relation;
5. Identifier la nature du problème et en contrôler l'évolution;
6. Etablir un plan thérapeutique.

VIII. Communication avec la famille du malade

- La rencontre médecin/patient/famille implique un interlocuteur supplémentaire : la famille, dont le mode de fonctionnement est inconnu et variable. Rencontrer une famille pour annoncer l'état de santé de leur proche doit se préparer,
- Le médecin doit maîtriser sa communication verbale et non verbale (analogique), qui exprime à notre insu nos émotions et nos sentiments. Il doit adopter une démarche structurée pour transmettre les informations aux proches :
- Prendre son temps et écouter les proches avant de parler.
- Puis prendre la parole et décrire l'histoire médicale du patient : de la prise en charge initiale, à l'admission dans le service et de ce qui a été mis en place pour le patient, puis énoncer un diagnostic et pronostique.

Conclusion:

- La société réclame des médecins plus humains et communiquant mieux avec les patients.
- Les cliniciens expérimentés et les chercheurs des domaines de l'éducation médicale et de la communication soulignent le rôle central de la communication médecin-patient dans la démarche clinique pour le succès des stratégies de diagnostic et de traitement.

« On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. » (Platon)*